



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE CONSTANTINE DR BEN BADIS
SERVICE DE NEUROLOGIE



ANNEE UNIVERSITAIRE 2025/2026
COURS DESTINE AUX EXTERNES DE 4^{eme} ANNEE - MEDECINE
MODULE DE NEUROLOGIE
PR KHELOUF MR

Constantine, le 26/10/2025

LES DEMENCES

Plan De Cours:

I.	INTRODUCTION- DEFINITION	1
II.	CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE :	2
III.	SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE :	2
IV.	DIAGNOSTIC POSITIF:	2
V.	DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :	4
VI.	DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :	4
VII.	COMPLICATIONS DES DEMENCES:	4
VIII.	PRISE EN CHARGE DES DEMENCES ;	5

I. INTRODUCTION- DEFINITION

La prévalence des démences augmente avec le vieillissement de la population et il est reconnu qu'elles sont en progression constante à l'échelle mondiale (1). Les démences constituent un problème de santé publique préoccupant. Elles représentent chez les personnes de plus de 65 ans un taux de plus de 50% (France). La démence est actuellement la septième cause de décès et l'une des principales causes d'invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde (2).

L'élément fondamental dans les démences est la précocité diagnostique et notamment pour les malades qui relèvent d'un traitement médicamenteux. La moyenne du délai diagnostique est estimé à deux ans (3).

Le syndrome démentiel est défini comme un ensemble de signes et symptômes qui se manifestent par un trouble des fonctions cognitives évoluant depuis plusieurs mois, dont la sévérité entraîne un retentissement sur la vie quotidienne du patient. L'organicité des lésions est prouvée et dans la plupart des cas de manière irréversible (1).

Le diagnostic de démence repose uniquement sur les données cliniques et les critères diagnostiques les plus récentes, établis par les sociétés savantes, actuellement on utilise beaucoup plus celles du guide DSM-5-TR (4). le diagnostic étiologique repose sur les explorations radiologiques (IRM) et biologiques, particulièrement l'étude de marqueurs spécifiques au niveau du LCR (5).

Il existe 3 entités fondamentales en pathologie qui peuvent donner un syndrome démentiel :

- Les démences dégénératives ;
- Les démences vasculaires ;
- Les démences mixtes : dégénératives avec composante vasculaire ;

II. CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE :

En général, le tableau inaugural d'une démence est fait de plaintes mnésiques sans altération des performances mnésiques avec des éléments dans la plupart des temps associées à un déficit de la mémoire dont il se traduit par :

- Des symptômes cognitifs : tel que l'oubli d'événements récents, une désorientation temporo-spatiale, troubles attentionnels, manque de mots, anosognosie.
- La perte d'autonomie fonctionnelle : La personne concernée nécessite l'aide pour effectuer les gestes de la vie quotidienne dont elle constitue un motif de consultation très fréquent. Ces perturbations peuvent entraîner une incapacité aux activités instrumentales comme prendre le transport en commun, se servir de son téléphone, gérer son budget.

III. SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE :

La présentation clinique du syndrome démentiel est faite de symptômes psychiatriques, de troubles du comportement et modification de la personnalité, par une perte d'intérêt pour des activités qui passionnait le malade pouvant aller jusqu'à un état dépressif majeur. Ainsi toute dépression chez un sujet avec plus de 65 ans doit conduire à réaliser une évaluation cognitive à la recherche d'une démence sous-jacente.

Une démence peut être révélée par une apathie, un délire, des hallucinations de toutes formes, une agitation motrice, des troubles du sommeil.

IV. DIAGNOSTIC POSITIF:

Le diagnostic positif de démence se base essentiellement sur les éléments suivants :

IV.1 Evaluation des fonctions cognitives aux tests psychotechniques :

L'évaluation des fonctions cognitives se fait à l'aide d'échelles spécifiques ou tests adaptés à chaque entité de démences et dont on cite essentiellement:

IV.1.1 Mini mental statut examination (MMSE):

Test facile, le plus communément utilisé, il comporte la cotation de 18 items avec un score compris entre 0 et 30. En sachant qu'un score de « 24 » est significatif d'une dysfonction cognitive alors qu'un score de « 27 » l'est rarement car les valeurs seuils pour interpréter ce test varient avec l'âge et le niveau d'éducation du malade. Par ailleurs, un score bas ne permet pas à lui seul de faire le diagnostic d'une démence (6).

IV.1.2 Evaluation cognitive rapide:

Une multitude d'échelles de réalisation brève et rapide sont dédiés aux déficits cognitifs, parmi les plus pratiques on trouve ;

- Le test de l'horloge : d'une durée d'environ 2 mn, consiste à demander au malade de dessiner sans modèle le cadran d'une montre, en représentant les chiffres et de dessiner les aiguilles pour figurer une heure demandée par l'examineur. Les résultats attendus ne dépendent pas du niveau d'éducation des patients.

D'autres tests permettent de dépister les troubles mnésiques en demandant au malade de mémoriser une liste de mots en facilitant leur rappel par l'indication :

- Le test des 5 mots de Dubois ; Consiste à faire apprendre au sujet une liste de mots avec indication qui consiste à indiquer au malade les catégories sémantiques des mots à mémoriser pour ceux non rappelés spontanément. Il évalue le rappel avant « Libre » et après « Différé » une épreuve interférente dont la cotation ne tiens pas compte du recours aux indices.

Dans les troubles de mémoire liés à une démence, le rappel différé est altéré et n'est pas amélioré par l'indication.

- Le mini Cog : Conçu comme un outil de dépistage de la démence en médecine générale, très court, fait intervenir plusieurs types de tâches en particulier l'apprentissage de mots et le test de l'horloge. Cette échelle a sensibilité et spécificité comparables à celles des tests plus longs.
- CODEX : il s'agit d'un test rapide, qui peut être réalisé en 3 minutes. Construit à partir de sous-items des tests MMSE et de l'horloge, avec une sensibilité et une spécificité respectivement de 92 et 85%.

IV.1.3 Evaluation de la perte d'autonomie fonctionnelle :

Si la perte d'autonomie est une conséquence des démences, elle peut être utile à leur repérage. L'étude PAQUID a montré que le besoin d'aide pour au moins une activité instrumentale de la vie quotidienne (IADL), tel que l'utilisation : du téléphone, des transports, prise des médicaments, gestion des finances...) avait une sensibilité et une spécificité respectivement de 94 et 71% dans le diagnostic de démence (7).

IV.2 Les consultations mémoires :

Ces pratiques sont d'une importance capitale et qui consistent à réunir dans une même unité de lieu et de temps des médecins spécialisés dans le diagnostic et la prise en charge de troubles cognitifs (gériatre, neurologue, neuropsychiatre...) et contribuent au diagnostic étiologique et permettent de formuler des orientations.

IV.3 Critères diagnostiques de la démence :

Le diagnostic de la démence est retenu après avoir rempli certains critères diagnostiques et dont les plus utilisées sont ceux de DSM-5-TR. Ces derniers posent le diagnostic de démence en cas de développement de déficits cognitifs multiples et qui se manifestant par :

- Déficit au niveau de la **mémoire** avec une altération de la capacité à **apprendre** de nouvelles informations ou pour **rappeler** l'information précédente.
- les fonctions cognitives perturbées peuvent être multiples et ce sont d'ordre :
 - Des troubles phasopraxiques.
 - Des troubles des fonctions exécutives (planification, organisation, séquençage, abstraction).

V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

Le diagnostic de démence n'est retenu d'une manière formelle après avoir éliminé les autres diagnostics à savoir :

- La confusion mentale : Elle a le caractère brutal et récent des troubles avec altération de la vigilance et onirisme.
- Anxiété et dépression : il ya des plaintes mnésiques sans altération objective des performances cognitives.
- La prise médicamenteuse (sédatifs, anticholinergiques,...)
- Déclin cognitif léger (MCI : Mild Cognitive Impairment) : Ces malades nécessitent un suivi rapproché car l'évolution vers une démence avérée est fréquente.

VI. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :

L'enquête étiologique dans une démence repose sur le mode d'installation des troubles et sur l'évolution, les données cliniques, le profil des troubles neuropsychologiques et sur l'imagerie cérébrale. Les démences sont classées en 2 catégories :

- Les démences dégénératives ; où la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente (70-80%).
- Les démences secondaires : Elles sont dans 20 à 25% des cas d'origine vasculaire et 9% de démences potentiellement réversibles.
 - La réalisation d'une IRM cérébrale est nécessaire pour identifier les lésions cérébrovasculaires, mais aussi l'hydrocéphalie chronique de l'adulte et les processus expansifs intracrâniens.
 - Un bilan biologique simple est utile :
 - ® Dosage de la TSH, ionogramme sanguin, bilan rénal, bilan phosphocalcique, dosage de la vitamine B12.
 - ® Sérologies et plus particulièrement de la syphilis et VIH.
 - ® L'EEG doit être réalisé en cas de syndromes démentiels d'évolution rapide ou ceux associer à des myoclonies ou bien à des crises épileptiques.

VII. COMPLICATIONS DES DEMENCES:

Certaines échelles ont été développées pour évaluer la sévérité des démences comme l'échelle de détérioration globale (global deterioration scale) ou l'échelle d'évaluation clinique de la démence ou CDR (clinical dementia rating).

L'évolution de la perte d'autonomie est une étape indispensable pour évaluer le retentissement. Les outils valides ADL et IADL sont les plus utilisés dans l'évaluation des activités de la vie quotidienne.

- Les troubles du comportement sont fréquents dans les démences fronto-temporales et vasculaires et sont regroupés sous le terme de « symptômes psychologiques et comportementaux ». Les troubles du comportement sont en relation souvent avec des difficultés d'adaptation à l'environnement et dépendent de l'entourage proche.

- L'épilepsie est beaucoup plus fréquente chez les sujets atteints d'une démence que chez les sujets du même âge non déments. La maladie d'Alzheimer augmente d'un facteur de 6 à 10 le risque de développer une épilepsie. Le rôle de l'entourage est capital pour identifier les crises focales simples ou à séméiologie complexe. Donc là il faut penser à l'épilepsie devant des épisodes de confusion mentale récurrents.
- La dénutrition protéino-énergétique est une complication fréquente et elle aggrave le pronostic. Une perte de poids de 2 Kg ou plus doit faire réaliser une évaluation précise de l'état nutritionnel.
- Les chutes et les troubles de la marche sont fréquents notamment dans les formes évoluées (démence à corps de Lewy, démence vasculaire) impliquant des mécanismes complexes : atteinte du contrôle moteur, troubles attentionnels, modification du système nerveux périphérique.

VIII. PRISE EN CHARGE DES DEMENCES ;

La prise en charge des démences est multidisciplinaire et doit être le plutôt possible afin de préserver le maximum de capital cognitif et elle consiste à :

- Traitement médicamenteux en fonction de l'étiologie ou symptomatique (Anticholinesthésiques...).
- Psychothérapie de groupe ou individuelle.
- Les aidants du malade représentent une aide majeure, permettent de préserver la qualité de vie du malade et sa sécurité en cas de perte d'autonomie.

Références bibliographiques ;

1. Masson E. EM-Consulte. [cité 24 oct 2025]. Syndrome démentiel : diagnostic et prise en charge. Disponible sur: <https://www.em-consulte.com/article/233162/syndrome-dementiel-diagnostic-et-prise-en-charge>
2. La démence [Internet]. [cité 24 oct 2025]. Disponible sur: <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
3. Édition professionnelle du Manuel MSD [Internet]. [cité 24 oct 2025]. Démence - Troubles neurologiques. Disponible sur: <https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-neurologiques/syndrome-confusionnel-et-démence/démence>
4. Elsevier Masson SAS [Internet]. [cité 25 oct 2025]. DSM-5-TR Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, texte révisé | Livre | 9782294781353. Disponible sur: <https://www.elsevier-masson.fr/dsm-5-tr-manuel-diagnostique-et-statistique-des-troubles-mentaux-texte-revisé-9782294781353.html>
5. M.Paulin et. Syndrome démentiel : Diagnostic et prise en charge. EMC-AKOS (Traité de Médecine) 2010 :1-10 [Article 5-0745].
6. Mini-Mental State Examination (MMSE) – Strokengine [Internet]. [cité 25 oct 2025]. Disponible sur: <https://strokengine.ca/fr/assessments/mini-mental-state-examination-mmse/>
7. Letenneur L. PAQUID : cohorte pionnière dans la mesure de la prévalence, l'incidence et les facteurs de risque sur Alzheimer. In: Semaine Data-SHS [Internet]. Paris, France: Plateforme universitaire de données de Nanterre and MSH Mondes and Plateforme universitaire de données des Grands Moulins and Université Paris-Cité and Plateforme universitaire de données de Paris-Saclay and MSH Paris-Saclay and Centre de données Socio-politiques (CDSP) and Sciences Po Paris; 2023 [cité 25 oct 2025]. Disponible sur: <https://hal.science/hal-04369457>.